فرسودگی شغلی
Burnout



فرسودگی شغلی یک سندرم روان‌شناختی است که در نتیجه قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض استرس‌های شغلی مزمن و مدیریت‌نشده ایجاد می‌شود. سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سال ۲۰۱۹ فرسودگی شغلی را در طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها (ICD-11) به‌عنوان یک «پدیده شغلی» (Occupational Phenomenon) ثبت کرده است نه یک بیماری پزشکی، بلکه عاملی که بر وضعیت سلامت تأثیر می‌گذارد.

نشانه‌ها

نشانه‌های جسمی:

خستگی مزمن و کمبود انرژی حتی پس از استراحت

سردرد، مشکلات گوارشی، اختلال خواب

افت سیستم ایمنی و بیمار شدن مکرر

نشانه‌های روانی/عاطفی:

احساس پوچی، ناامیدی یا گیر افتادن

بدبینی نسبت به کار، همکاران یا کل حرفه

کاهش انگیزه و حس بی‌معنایی در کار

تحریک‌پذیری و کاهش تحمل

نشانه‌های رفتاری:

افت عملکرد و بهره‌وری

اجتناب از مسئولیت‌ها، تعویق‌کاری (procrastination)

انزوای اجتماعی از همکاران

افزایش مصرف کافئین، الکل یا سایر مواد برای کنار آمدن

پیشینه مفهوم: واژه Burnout اولین بار توسط روان‌شناس هربرت فروینبرگر (Herbert Freudenberger) در سال ۱۹۷۴ معرفی شد، زمانی که او حالت فرسودگی را در کارکنان کلینیک‌های داوطلبانه مشاهده کرد. اما کسی که این مفهوم را به یک حوزه پژوهشی جدی تبدیل کرد، کریستینا مسلش بود.

مکانیسم فیزیولوژیک: فرسودگی شغلی صرفاً یک حالت ذهنی نیست استرس مزمن محور HPA (هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال) را مختل می‌کند. در حالت عادی، کورتیزول در پاسخ به استرس ترشح می‌شود و بعد از رفع تهدید، سطح آن برمی‌گردد به حالت پایه. اما در فرسودگی مزمن، این سیستم «دیس‌رگوله» می‌شود برخی مطالعات سطح کورتیزول صبحگاهی پایین‌تر از حد طبیعی را در افراد دچار فرسودگی شدید نشان داده‌اند (پدیده‌ای شبیه به آنچه در اختلال استرس پس از سانحه هم دیده می‌شود).

مدل JD-R (Job Demands-Resources): یکی از چارچوب‌های علمی رایج دیگر، مدل «تقاضا-منابع شغلی» است که می‌گوید فرسودگی زمانی رخ می‌دهد که تقاضاهای شغلی (حجم کار، فشار زمانی، تعارض نقش) به‌طور مداوم از منابع در دسترس (استقلال، حمایت اجتماعی، بازخورد، فرصت رشد) پیشی بگیرد. این مدل برخلاف MBI که بیشتر توصیفی است، جنبه‌ی پیش‌بینی‌کننده و مداخله‌ای قوی‌تری دارد و در مشاوره سازمانی خیلی کاربردی‌تره.